



3

56. ÅRGANG | 03 • 2019

ARTIKEL

Tema

Når krisen rammer
– pædagogiske og psykologiske
perspektiver på krisehåndtering

PPT nr. 3-2019

**Fra fokus på uventede reaktioner
til strukturelt set up inden for
operationel kriseintervention**

Af Robert Jonassen

PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK TIDSSKRIFT
FORLÆGGET SKOLEPSYKOLOGI • PÆDAGOGISKE PSYKOLOGERS FORENING

Fra fokus på uventede reaktioner til strukturelt set up inden for operationel kriseintervention



Gennem virkeligheds nære oplevelser og erfaringer sætter denne artikel fokus på en række overordnede krisepsykologiske tematikker og erfaringer, som er gjort gennem deltagelse i et antal større og mindre kriser i ind og udland. Samtidig reflekteres der i artiklen over betydningen af at understøtte beredskabsplaner ved brug af fx simulering og øvelse.

Af Robert Jonassen, Chief Psychologist, SOS International a/s, Health Operations

Akutte og voldsomme hændelser kan typisk vende op og ned på reaktionsmåder og medføre umiddelbar stress og krisereaktioner. De fleste der udsættes for en akut og voldsom hændelse bliver rystet i forståelsen af sig selv og omverdenen i kortere eller længere tid. Følelsen af et forandret selv og manglende handlingsstrategier kan derfor ofte betragtes som "normal" tilstand set i relation til en voldsom og kritisk hændelse.

At være i en akut krise ledsages imidlertid ofte af en usædvanlig påvirkning såvel biologisk, psykologisk som socialt. Tilstanden kan fornemmes dramatisk og rækker ud over den normale fornemmelse af selv. Når personer udsættes for en kritisk hændelse vil nogle af de reaktioner de fornemmer ofte også være ledsaget af en ændret psykisk såvel som kropslig tilstand. Den ramte har været i og/eller er fortsat i en overlevelseshen eller alarm tilstand.

Er akut krise intervention anderledes med børn og unge?

Generelt peger forskning og praksiserfaringer på at børn og unge er særligt sårbare i relation til voldsomme og kritiske hændelser. Meget tyder på at børns reaktioner kan være mere subtile og mere konkret funderet end hos voksne, der har et mere veludviklet perceptions og begrebs apparat. Samtidig er der en udbredt opfattelse af at børn anses for at være mere resistente

Praksiserfaringer og forskning peger imidlertid på at der er en øget risiko for at børn og unges symptomer i tiden efter en voldsom akut hændelse overses eller forveksles med andre symptomer. Eksempelvis er det velkendt at forældre som står tæt på børn og unge der har været udsat for en voldsom hændelse tendere at underrapportere omkring børnenes symptomer.

Der eksisterer derfor en reel risiko for, at børn og unges behov overses og de ikke får den adækvate behandling

efter en voldsom hændelse som egentlig er nødvendig. Der er derfor ofte behov for at interventioner i forhold til børn kan ske akut såvel som over tid og interventionerne er individuelt tilpasset, for netop at undgå udviklingen af mere permanente patologiske og traume relaterede tilstande herunder udvikling af PTSD.

Det er ikke mindst derfor en særlig kompleks opgave at yde krisebistand til børn og unge der har været ude for en alvorlig og akut hændelse.

Formålet med denne artikel er imidlertid ikke at lave en systematisk gennemgang af krisereaktioner hos børn og unge. Det er der efterhånden lavet ganske gode bøger omkring og der rettes heldigvis mere og mere forskningsfokus på børn og unge i forhold til (akutte) reaktioner som følge af eksponering overfor voldsomme hændelser. Fokus i nærværende artikel er, at dele erfaringer og refleksioner fra det krisepsykologiske arbejde der dagligt udføres i en større nordisk kriseforening. Det er artiklens intention gennem eksempler, at sætte fokus på at psykologisk belastning i relation til beredskab, forberedelse og simulering. Artiklen har derfor til formål overordnet at inspirerer til refleksion over parathed i forhold til håndtering af akutte.

Vor psykologenhed yder bistand til medarbejdere der til dagligt arbejder med børn og unge i en række større danske kommuner samt rejsende, herunder turister og skoler på studietur m.v. Gennem dette arbejde har organisationen stor erfaring med akut krisintervention på stedet ("on site").

I forbindelse med terroranslag i fx London, Bruxelles, Niece mv. har vi

haft udsendt og indsat specialiserede og tværfaglige kriseteams for at yde psykologisk krisestøtte til de berørte såvel børn, unge og voksne.

Overvejelser om beredskab

I det daglige arbejde med krisepsykologiske indsatser akkumuleres der naturligtvis brugbare erfaringer, som er værd at formidle videre.

Det er naturligvis væsentligt at have et stående beredskab som respondere i forhold til den sandsynlige hændelse der vil kunne opstå. Det kan være enkelt kritiske hændelser, maseskade fx busulykker, terror anslag og naturkatastrofer, bortkomne mv. Et beredskab skal gerne kunne aktiveres 24 timer i døgnet. Idet kriser beklageligvis har det med at hænde når det mindst ventes eller er opportunt.

Ved SOS International håndteres i princippet kriser "på samlebånd". Der benyttes derfor begreber som høj og lav sæsoner for kriseindsats (typisk ferie tid – sommer og vinter). De medarbejdere der udfører den krisepsykologiske indsats er erfarende nordiske psykologer der er specialister på området. De er særligt udvalgt og tilknyttet et team med henblik på at udføre de indkomne opgaver i indland og udland.

Vidner til terror

Den 3. juni 2017 gennemførtes et terrorangreb på London Bridge Jeg var en del af det udsendte et kriseteam der skulle assistere en lærergruppe der var på studietur med en elevgruppe (15-16 årige elever). En række af de danske elever havde inden for 10-15 meter oplevet terror angrebet på London Bridge. At yde en sådan indsats



Den 3. juni 2017 gennemførtes et terrorangreb på London Bridge.

kræver et stående beredskab og kommer i første omgang til at handle meget om at skabe ro, struktur og hjælpe med at genoprette rutiner. Men ikke mindst skabe empowerment til lærergruppen og ledelsen, så den normale struktur kan genetableres. Sideløbende med den mere kliniske del af krisearbejdet udføres.

Men reaktionsmønstre kan være vidt forskellige i denne aldersgruppe og meget svingende. Ud over de mere forventelige reaktionsmønstre; forhøjet arousal niveau (øget beredskab), svært ved at sove, vanskeligt ved at huske hændelsen i sin helhed, uvirkelighedsfølelse, tilbagevendende tanker og billeder og ikke mindst aktivering af parallelle traumer og stress.

Men netop derfor bør en intervention som udgangspunkt altid være skalerbar, fleksibel og ikke en ensidig forudbestemt "hyldevare". Alle kriser er i deres essens forskellige og der er som altid tale om kriser i krisen, som ind-

satsen er nød til at rette opmærksomhed imod. For at kunne nærme sig det punkt, hvor den primære kriseindsats kan afsluttes. I forhold til London blev det besluttet at starte med gruppesamtaler inddelt efter, hvor de unge var på hændelsestidspunktet. Herefter blev der afsat individuelle tider til alle og efterfølgende igen gruppesamtaler og igen individuelle sessioner. Det kan i særlig grad med børn og unge være væsentligt, at være meget tydelig omkring rammer og struktur, men samtidig for enhver pris undlade rigiditet.

I forhold til reaktioner på hændelse var det mest overraskende imidlertid drengegruppen, der havde været tættest på og overværet hændelsen inden for 10 meters afstand. Det der tilsyneladende rystede dem allermest var at se politiet løbe for livet og ikke være i stand til at stoppe terroristerne. Det var det scenarie der havde brændt sig fast og optog drengene i dagene efter. Det var ikke de døende mennesker de

havde overværet blive stukket ned lige på den anden side af gaden. Det var tydeligt at deres opfattelse af verden var blevet forandret (world assumption).

Følelsesmæssigt virkede deres reaktioner adækvate og var generelt sammenhængende med deres egen evne til at bringe sig i sikkerhed ved at løbe væk. Men forventningen om at politiet klare situationen og skaber ro og orden, som det er blevet simuleret og lægt tusindvis af gange på børneværelset stod for fald. Det gjorde dem tydeligt grundlæggende usikre på om verden omkring dem. Ligesom den grundlæggende antagelse af at ekstremt kaos kan bringes til orden var blevet gennemhullet.

I det ovenstående eksempel er der tale om en hændelse som potentielt bringer angst og frygt hos alle og forældregruppen modtog derfor sideløbende ligeledes briefing primært i form af psykoedukation i forhold til egne reaktioner og deres børns reaktioner. Forældrene var i løbende dialog med deres børn og kunne igennem dem ligeledes følge med i hvordan krisearbejdet skred frem. Skoleklassen gennemførte (imidlertid efter en to dages intensiv krisepsykologisk indsats) studieturen. Dog blev vurderingen at enkelte elever måtte tages hjem grundet særlige voldsomme reaktioner.

Sorg og krise

Anderledes forholder det sig så snart der er tale om død eller lemlæstelse blandt nære. Jeg var en del af kriseteamet, der blev deployeret for at assistere en svensk skoleklasse (2014) der havde været involveret i et voldsom trafikuheld i Kenya hvor 2 af de delta-

gende elever mistede livet og et antal elever var kvæstet og indlagt på hospital.

Her spillede sorg, skyld mv. naturligvis en væsentlig rolle blandt de skadelidte og de medrejsende. Det har selvsagt en betydning for indholdet i interventionen. Fx skal der rettes mere opmærksomhed mod det at skabe empowerment sikkerhedsdomæner, fordi eksisterende struktur og roller forandres betydeligt.

Præmorbiditet bliver væsentlig i den indledende fase af indsatsen. Hvor det normalt giver mening at tale med de unge om hændelsen for at strukturere og kognitivt bearbejde en hændelse er udfordringen en anden, når de skadelidte samtidig er ramt af voldsom sorg. Her vurderedes det hensigtsmæssigt, at arbejde med en vis følelsesmæssig bearbejdning af de implicerede. Og lære dem at kende enkeltvis ikke mindst for at få et indtryk af, hvem de var inden hændelsen indtræf. Efterfølgende var det muligt at åbne op, for en plumbaseret bearbejdning af hændelsen. Således vil metodikken der arbejdes ud fra ofte afhænge af situationen.

Beredskabsplaner bør simuleres

Bl.a. i situationer som de beskrevne er det væsentligt, at have en krisestab og et beredskab. Vores faste stående krisestab træder sammen for tværfagligt at vurdere hændelsen, hvilket gøres ud fra en lang række parametre før igangsættelse af selve indsatsen. Det omfatter naturligvis en geografisk validering af de skadelidtes fysiske lokation (skadestedets anatomi), antal, tilstand, vurdering af den strukturel robusthed på ste-

det (er der lokale støtte indsatser). Det er ikke mindst væsentligt at forholde sig til før-under og efter dimensionen i indsatsen. Samtidig skal indsatsen kunne "genforhandles" løbende.

På baggrund af disse og andre indikationer/informationer igangsættes indsatsen. Krisestaben samler den operative del af kriseteamet. Dette gøres ud fra informationer om skadeslidte og teamet sammensættes med de kompetencer der umiddelbart vurderes at møde situationen. Inden for få timer vurderes det gerne ud fra input fra personer der er på skadesstedet, hvordan indsatsen initialt skal/kan forme sig. Er der overhovedet indikation for fysisk tilstedeværelse af krisepsykologer? Kan de skadeslidte bedst hjælpes ved en virtuel klinik (VCR eller telefon)? hvordan kan vi i øvrigt være til stede på en måde der ikke eskalere krisen yderligere? Er der hensigtsmæssige lokaliteter til udførelse af kriseindsatsen?

Krisehåndtering er komplekst arbejde og det kræver som beskrevet i litteraturen blandt andet af Mitchell en høj grad af koordination, timing organisation og evne til løbende reorganisering. Det har imidlertid ikke uvæsentlig betydning når der på forhånd eksisterer en form for struktur der tager højde for en række af de grundscenarier, der uvilkårligt kan udspringe af en kritisk hændelse.

Ofte høres i virksomheder og organisationer følgende sætning; "jo, da, vi har lavet en beredskabsplan hvis der skulle ske noget". Personligt er jeg mere rolig hvis meldingen er; "vi har en beredskabsplan klar når der sker noget.

Så et af de første spørgsmål det vil hensigtsmæssigt at stille er om der er gjort overvejelser i retning af hvordan en kritisk hændelse kan håndteres. Hvordan skal vi gøre det på den her skole?, Børnehave? Arbejdsplads? Er der en beredskabsplan med scenarier, som tager højde for kritiske enkelt og/eller masseskade hændelser? Har vi øvet os i forhold til;

- 1) individuelle akutte kritiske hændelser og
- 2) større kritiske hændelser (masseskader).

Er der et adækvat beredskab, der sikrer en fornuftig organisering når den kritiske hændelse rammer? Organisering, forberedelse og simulering danner som et udgangspunkt et grundlæggende fundament for en konstruktiv kriseindsats.

Øvelse betaler sig

I konfrontationen med berørte af en krise, hvor indsatsen ikke er overordnet styret og støttet, udvikler kan meget nemt udvikle sig til en ujævn affære for de der yder den direkte bistand. Belastningsgraden i udførelsen af et dedikeret stykke krisearbejde øges og det kan tære på det nødvendige, overskud og lederskab som en krisepsykolog skal være i besiddelse af.

Selvfølgelig er det også krisepsykologens opgave netop, at tilføre situationen stabilitet mv. bl.a. ved at validere sin egen rolle i situationen og sikre den rette empowerment (sætte andre i stand til) Dette gøres ligeledes bedst hvis allerede har en struktur at forhol-

de sig til som optimalt er indøvet og trænet.

Det må derfor anbefales at kriseindsats øves på lige fod med brandøvelser på skoler og institutioner. Simuleringer af dele af et beredskab kan gennemføres med stort udbytte.

For et år siden var jeg en del af indsatsen på en institution uden for Århus. Her blev der afleveret et brev indeholdende en bombetrussel i receptionen. Der var en beredskabsplan, men de pædagogiske medarbejdere blev i kampens hede sendt ud for at lede efter en evt. bombe eller andet mystisk på institutionen. Umiddelbart en rationel ledelses beslutning i forhold til at forsøge at forhindre/standse ulykken.

Den efterfølgende kriseindsats afslørede at det var en dyr beslutning fordi medarbejdernes oplevede frygt ved selv, at skulle opsøge en mulig bombe eskalerede da faren var drevet over. Mens hændelsen pågik ønskede de fleste at hjælpe og følge de udstedte direktioner. Men efterfølgende refleksion bibragte medarbejderne en kaskade af frygt, ængstelighed, skyld og skam over at have sat deres live på spil.

Nærværende eksempel peger på at en aktiv beredskabsplan kunne have været til stor nytte og sparet medarbejderne for en række psykiske efter/overgangsreaktioner. Den efterfølgende psykologiske indsats blev væsentlig mere kompliceret og omfattende, end det ville have været tilfældet, hvis en beredskabsplan havde været klar og indøvet. Det skal for god ordens skyld nævnes at selve bomben viste sig at være "falsk alarm", hvilket politi efterfølgende kunne konstatere.

Men her var den psykologiske skade imidlertid sket i forhold til personalet, hvor det psykologiske belastning blev betydelig større end det havde været nødvendigt

Simuleringer øger kvaliteten

Jeg deltog forleden i en simulering i en førende dansk medie virksomhed. Der blev konstrueret en hændelse af et sikkerheds firma, der leverede en meget livagtig simulation med meget realistiske indspil til en krisestab. Her blev det tydeligt, at det kan betale sig, at gennemførte rollespil og live simuleringer fx, med deltagelse af støttepersonel der ude fra skal understøtte kriseindsatsen ved en store kritisk hændelse.

Det var tydeligt at der opstår dilemmaer selvom beslutningskraften i den etablerede krisestab var stor. Men konfrontationen med pårørende (skuespilere) der ringede med skælvende stemme var fx tydeligt udfordrende og gav pludselig anledning til, at "slipsekunden" blev løsnet og der kunne med et fornemmes usikkerhed i forhold til tilgang og beslutningstagelse. Samt at der bredte sig en generel usikkerhed i krisestaben. Fik vi lige gjort det her rigtigt? Hvilket naturligtvis var en ekstremt værdifuld erfaring at gøre sig under en simulering og ikke i forbindelse med en "live" krise.

For hvornår gør vi det mest hensigtsmæssige og hvad er det egentlig? Virker beroligelse eller tabes troværdighed ved, at underspille situationens alvor?

Hvilke indsatser skal der sættes i værk og hvornår. Hvem skal indsættes? Hvor længe og hvor mange? Hvil-

ke informationer er vigtige at indsamle for at forberede indsatsen? Dette er blot et fåtal af spørgsmål som rejser sig når der fx er en større eller mindre kristisk hændelse udspiller sig. Nå ja, hvordan håndteres pressen bedst? Og hvordan når man selv er en medievirksomhed?

Der er således flere elementer der med hæld kan øves igennem for at få en så god respons og effekt fra den krestab/ledergruppe der skal håndtere en situation. Så med andre ord øvelse og simulering er et nødvendigt must på linje med øvelser der løbende udføres fx i forhold til brand mv.

Selvom organisationer og institutioner i stigende grad er blevet mere bevidst om værdien af en aktiv beredskabsplan, er der fortsat et stort antal virksomheder og organisationer der siger, "jo, da vi har en plan i skuffen "hvis" det sker..."

Afrunding

Som det er nævnt i denne artikel, der primært bygger på 1. hånds erfaringer med akut kriseintervention i forhold til masseskade og enkelt intervention kan følgende vigtige læringsmål opsummeres.

- Børns reaktioner på krise kræver ofte en skalerbar og fleksibel indsats
- Børn og unge er særligt sårbare og risikoen for at de selv eller omsorgspersoner omkring dem underrapportere er ofte pre dominant
- Forældrenes/omsorgspersonernes reaktioner skal stimuleres, idet børn og unge relatere sig til de voksne (empowerment)

- Kriseintervention er en kortere intensiv indsats som særligt med børn og unge skal følges op af andre indsatser, idet symptomer og reaktioner hos børn kan være mere subtile.
- Arbejdet med børn og unge vil altid foregå i tæt dialog med familien/forældre.

Opsummerende har arbejdet med børn og unge i akutte kriser givet anledning til særligt følgende fokusområder/refleksions punkter:

- Hurtig udrykning – vigtig at kunne være ved den skadesramte inden for så kort tid som muligt.
- Det skal besluttet om fx forældre skal komme/ikke komme/plan for interventionen
- Gruppen skal som udgangspunkt holdes samlet de skal have mulighed for at tale sammen i sikkert rum sammen eller enkeltvis under ledelse af krisepsykologer
- Forældrene skal informeres løbende og klædes på til at støtte op om børn og unge (psykoeduktation)
- Opmærksomhed på efterreaktioner og hvor børn og unge kan få yderligere hjælp og støtte
- Viden om tab, sorg og krise hos børn og unge er en forudsætning

Beredskabet

Opsummerende har arbejdet med akutte kriseindsatser givet anledning til særligt følgende fokusområder/refleksions punkter:

- Det er vigtigt at have en aktiveret beredskabsplan

- Det er væsentligt at øve/simulere sit beredskab eller elementer af dette
- Organisering i form af en overordnet koordinerende og beslutnings tagende krisestab/gruppe har stor betydning for kriseindsatsens stabilitet.
- Koordiner beredskabsplanen med forventede eksterne bidragydere
- Indbyg dynamiske scenarier for om og reorganisering af kriseindsatsen

Referencer

Mitchel J.T. & Everly, G. (2001) *Critical Incident Stress Debriefing: An operational Manual*

Dyregrov, A (1998). *Psychological Debriefing an Effective Method? TRAUMATOLOGY*, 4 (2) Article 1.

Dyregrov, A. (1983). Stress–reaksjoner hos hjælpere. *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 20, 674–679.

Dyregrov, A. (1985b). Krisehjelpsteam. *Tidsskrift for Norsk Psykologforening*, 22, 206–210.

Leonore Terr (1990) TOO SCARED TO CRY

White M. (2004b: Working with people who are suffering the consequences of multiple trauma: a narrative perspective. “ The International journal of Narrative therapy and Community work

Stephen Joseph & P. alex Linley, (2008)Trauma recovery and Growth

Carla Smith Stover, Hilary Hahn & Steven Berkomowitz (2010) *Psychol Trauma* Sep; 2 (39):159-168